2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo

30 de abril a 2 de maio de 2026

MACEIÓ ◦ ALAGOAS

Realização
ABEFACC
AAMFC

Fortalecimento do cuidado territorial por meio da organização das visitas domiciliares na Estratégia Saúde da Família

Maria Brennda Moraes de Gusmão[1]; Taíssa Kelly Novais Veiga[2]; Laís Souza da Silva Vitorino[2]; Maria Deysiane Porto Araújo[2].
1. Centro Universitário CESMAC
2. Universidade Federal de Alagoas, *campus* Arapiraca

Figura 1: Formulário de vulnerabilidade para consultas domiciliares disponível para os Agentes Comunitários de Saúde.

COMO GARANTIR A EQUIDADE NO SUS NO CONTEXTO DAS CONSULTAS DOMICILIARES?

Uma ferramenta simples de estratificação de risco pode transformar a organização das visitas domiciliares, tornando o cuidado na APS mais justo, eficiente e centrado nas vulnerabilidades reais dos pacientes.

Introdução

A atenção domiciliar é estratégica para o cuidado longitudinal e integral na Atenção Primária à Saúde, pois possibilita compreender o contexto social e familiar, além dos fatores biológicos. Porém, a ausência de critérios sistematizados pode comprometer a equidade e a organização das visitas.

Objetivos

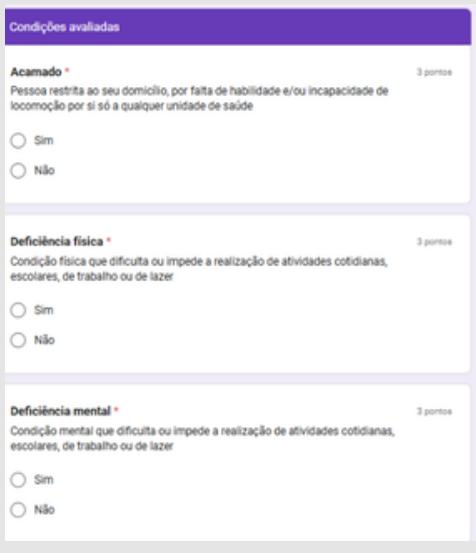
Relatar a experiência de um projeto de implementação de instrumento simplificado de estratificação de risco para qualificação da agenda de visitas domiciliares em uma Unidade Básica de Saúde de Arapiraca-AL, desenvolvido durante estágio em Saúde da Família do curso de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, envolvendo equipe multiprofissional.

Métodos

Identificação de fragilidades → Revisão da literatura → Planejamento entre Dez/25 a Fev/26 → Elaboração da ferramenta e Atividade formativa

Resultados

A partir da revisão da Escala de Coelho-Savassi, foi criado formulário vinculado à planilha de classificação de risco, a qual é baseada em critérios clínicos, sociais e de acesso, para ajudar na identificação de pacientes prioritários à visita domiciliar e na operacionalização por agentes comunitários de saúde, enfermeiros e médicos.



Planilha

PACIENTE	CPF/CNS	ACS	CONDIÇÕES	OUTRAS CONDIÇÕES	PONTOS	RISCO	PERIODICIDADE	DATA DA ÚLTIMA VISITA	DATA DA PRÓXIMA VISITA	STATUS
NOME	**********	******	• Maior de 70 anos de idade • Hipertensão Arterial Sistêmica • Diabetes mellitus	* Câncer de próstata	3 / 30	Sem risco	A cada 6 meses	19/03/2026	19/09/2026	Atualizado
NOME	**********	******	• Deficiência física • Deficiência mental • Baixas condições de saneamento • Desnutrição • Drogadição • Desemprego • Maior de 70 anos de idade • Hipertensão Arterial Sistêmica • Diabetes mellitus	* Dificuldade auditiva e Incontinência urinária	19 / 30	Risco máximo	A cada 2 meses	12/01/2026	12/03/2026	Atrasado

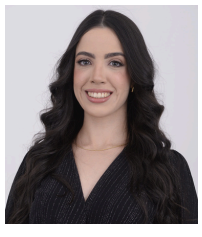
Figuras 2 e 3: Formulário de vulnerabilidade de pacientes domiciliados vinculado à planilha de classificação de risco.

Considerações finais

A iniciativa demonstrou que instrumentos simples, construídos coletivamente, podem qualificar o cuidado territorial e otimizar recursos na APS, reforçando a importância da educação permanente como estratégia de gestão.

Centro Universitário CESMAC
MARIA BRENNDA MORAES DE GUSMÃO
MÉDICA RESIDENTE EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

E-mail: brenndagmed@gmail.com



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

CESMAC CENTRO UNIVERSITÁRIO